فحص العمود الفقري والطرفين السفليين

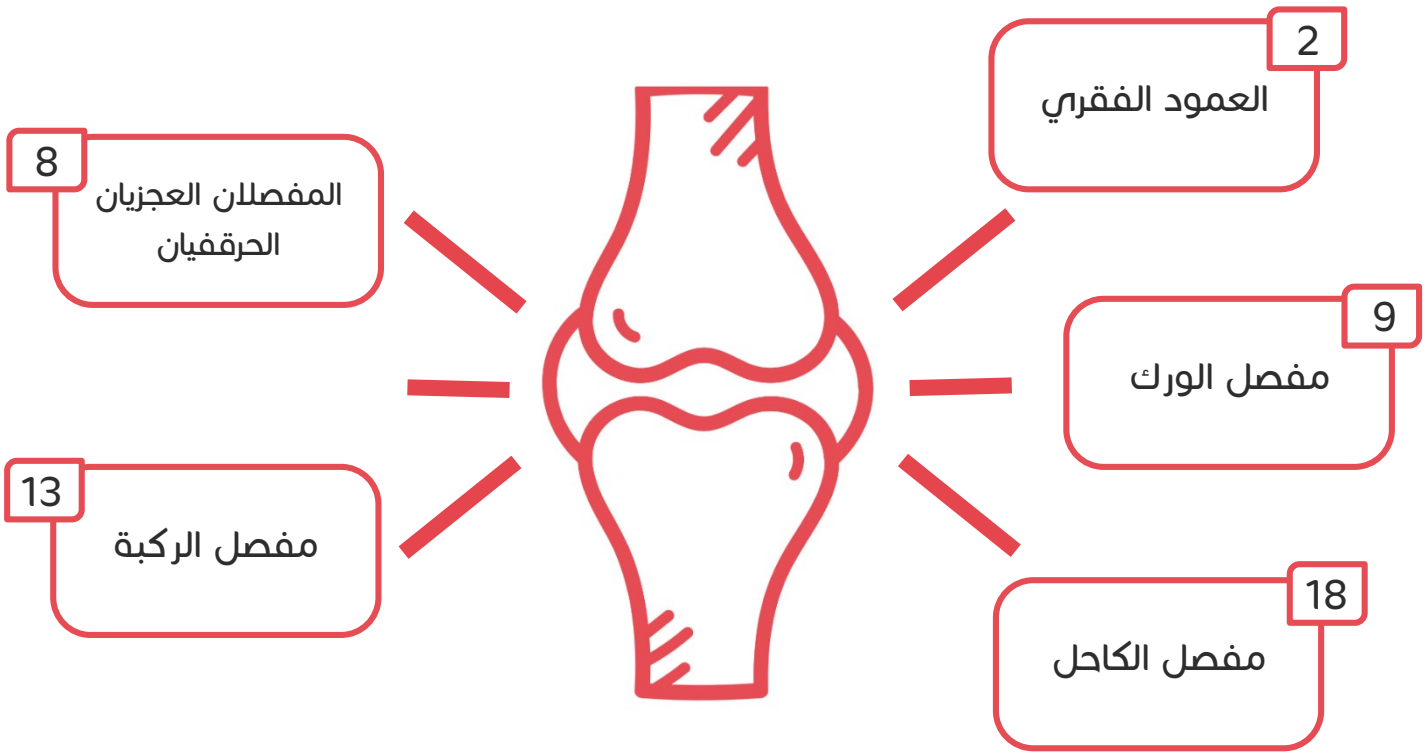
د. تسنيم دريعي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

أصدقاءنا الأعزاء، نقدم لكم المحاضرة الثانية من قسم د. تسنيم في المهارات الرثوية، فبعد أن تحدثنا عن فحص مفاصل الطرفين العلويين، نتابع اليوم مع دراسة العمود الفقري ومفاصل الطرف السفلي وآلية فحصها

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

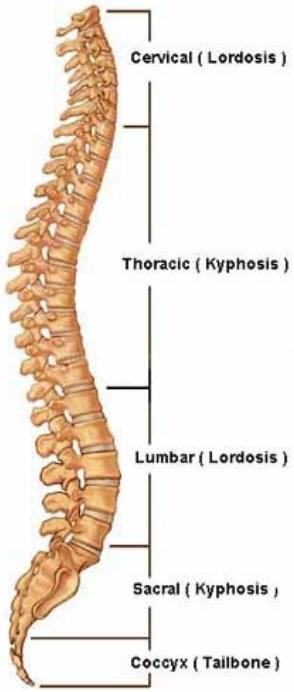


العمود الفقري Spine

- يتكون العمود الفقري من 33 فقرة:

7 فقرات رقبية	12 فقرة ظهرية	5 فقرات قطنية	5 فقرات عجزية	4 فقرات عصعصية

- تُعد آلام العمود الفقري من أشيع الشكايات عالمياً.
- توجد في بنية العمود الفقري **انحناءات فيزيولوجية**، وهي هامة جداً لدعم بنية جسم الإنسان وحماية النخاع الشوكي، هذه الانحناءات هي:



القعس (البزخ) الرقبي Cervical lordosis	انحناء العمود الفقري بالمستوى السهمي، بحيث يكون التحدب نحو **الأمام**
الحدب الظهري Dorsal kyphosis	انحناء العمود الفقري بالمستوى السهمي، بحيث يكون التحدب نحو **الخلف**
القعس (البزخ) القطني Lumbar lordosis	انحناء العمود الفقري بالمستوى السهمي، بحيث يكون التحدب نحو **الأمام**
الحدب العجزي Coccygeal kyphosis	انحناء العمود الفقري بالمستوى السهمي، بحيث يكون التحدب نحو **الخلف**

فحص العمود الفقري

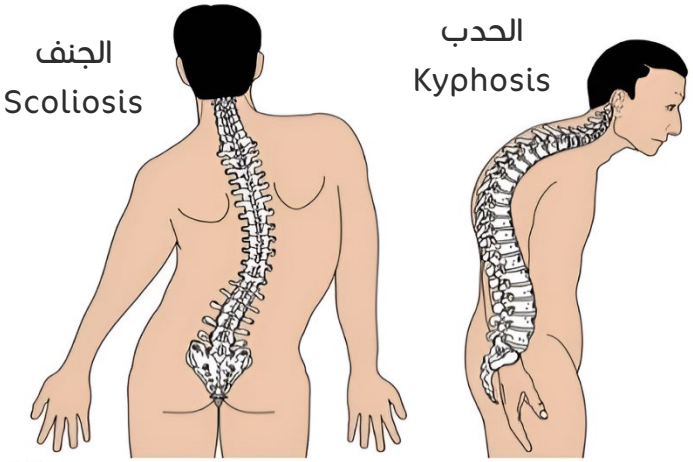
❖ يكون تسلسل الفحص كالآتي:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة

أولاً: التأمل Inspection:

☑ نتأمل الهندسة السوية للفقار للكشف عن **التشوهات** كالحدب، الجنف، القعس القطني الفيزيولوجي (الحمل والبدانة)، غياب القعس القطني.

☑ كما نبحث عن **التورمات والآفات الجلدية**.



ثانياً: الجس Palpation:

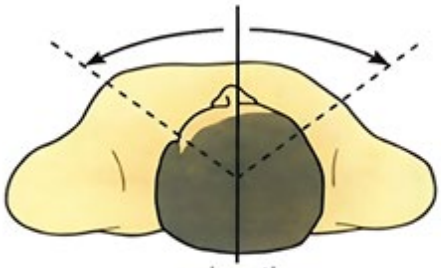
- ☑ نتحرى الإيلام بالجس.
- ☑ نجس النواتئ الشوكية والفقرات والعضلات جانب الفقار.
- ☑ النقطة العلام هي **الناتئ الشوكي للفقرة الرقبية السابعة**.

ثالثاً: فحص الحركة Movement:

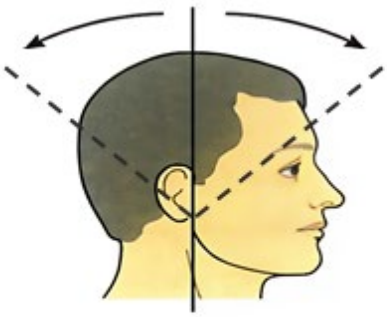
- ☑ الجزء الأساسي **المتحرك** من العمود الفقري هو العمود الرقبي والعمود القطني.
- ☑ أما العمود الصدري **فيتحرك بدرجة قليلة** وله حركة دورانية أساسية.
- ☑ أما العصعص **فلا يتحرك أبداً**.

1. العمود الرقبي:

العطف	• نطلب من المريض أن يلمس صدره بذقنه (حركة الرأس نحو الأمام).
البسط	• نطلب من المريض أن ينظر للأعلى والوراء من فوق كتفيه (حركة الرأس نحو الخلف).
الانحناء إلى الجانبين	• أن يميل رأسه بحيث تلامس أذنه كتفه ولكن من دون معاوضة الكتف (أي دون رفع الكتف).
الدوران	• نفحص الدوران إلى الجانبين أي ينظر من فوق الكتف إلى الخلف قدر استطاعته (المدى الطبيعي 45 درجة *).


الدوران


الوضعية الحيادية


العطف والبسط

2. العمود الظهري:

✓ مسؤول بشكل أساسي عن **الحركات الدورانية**، ولفحصها نثبت الحوض بإجلاس المريض على كرسي، ثم ندعه يقوم بالحركات السابقة.





3. العمود القطني:

✓ مسؤول بشكل أساسي عن:

العطف والبسط	الانحناء الجانبي لليمين واليسار	الدوران الجانبي لليمين واليسار



فحص الفقرات الصدرية والقطنية

بعض اختبارات فحص العمود الفقري

1. اختبار ضغط الرأس:

➢ نطلب من المريض النظر للأعلى ثم نجري حركات الانحناء الجانبي للرقبة مع الضغط على الرأس، فإذا وجدت **آفة انفتاق نواة لبية يتحرض الألم**.

2. اختبار قذال - حائط:

➢ إذا طلبنا من المريض أن يقف وظهره ملاصقاً للحائط يجب أن تكون المسافة الطبيعية بين القذال والحائط **صفر** وكلما زادت هذه المسافة دل ذلك على وجود **تحدد في حركة البسط للعمود الرقبي**.

3. اختبار زنمة - حائط:

➢ عند الوقوف بالوضعية السابقة يجب أن تكون المسافة الطبيعية بين الزنمة "أي القطعة البارزة من الأذن الخارجية" والحائط **10 سم** وكلما زادت هذه المسافة دل ذلك على وجود **تحدد في حركة البسط للعمود الرقبي**.

توضح الصورة المجاورة تقييم حركة البسط في العمود الرقبي عبر قياس كل من:

- المسافة بين القذال والحائط (المسافة الطبيعية 0 سم).
- المسافة بين الزنمة والحائط (المسافة الطبيعية 10 سم).



4. اختبار الاتساع الصدري:

- حيث نضع اليدين في مستوى حلمتي الثدي أو في مستوى الورب الرابع ونقارب الإبهامين على الظهر فيحصران ثنية جلدية في حالة زفير عميق، ونحدد المسافة بينهما.
- ثم نطلب من المريض القيام بشهيق عميق إذ يجب أن يكون تغير (زيادة) المسافة بينهما **أكثر من 4-5 سم** في الشخص السوي، **أما إذا كان مقدار تغير المسافة أقل فيوجد تحدد**.



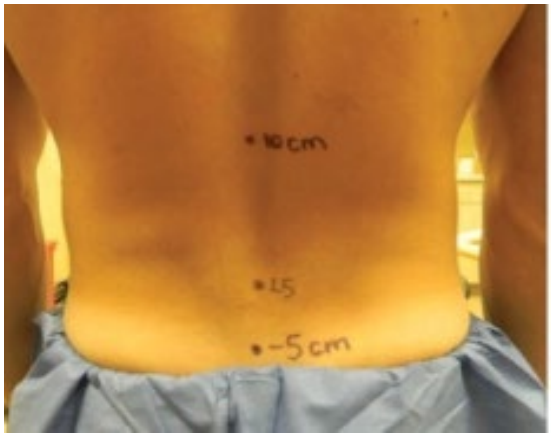


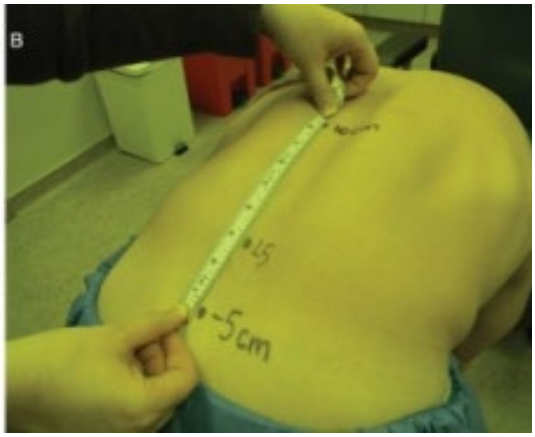
توضح الصورة تقييم الاتساعية في العمود الظهري (في الحالات الطبيعية يكون الفرق بين الشهيق والزفير 5 سم أو أكثر)

مقطع فيديو يوضح اختبار الاتساع الصدري

5. اختبار شوبر:

- يقيس درجة **تحدد العطف الأمامي للعمود القطني** عبر قياس مقدار **تباعد الفقرات عن بعضها أثناء الانحناء**.
- يكون المريض بوضعية الوقوف، نحدد على عموده الفقري ثلاث نقاط:
  1. نقطة بمنتصف **الخط الواصل بين الشوكين الحرقفيين العلويين الخلفيين** (بين الفقرات القطنية 4 وَ 5).
  2. نقطة أخرى فوقها بـ 10 سم.
  3. بالإضافة للنقطتين السابقتين نحدد نقطة ثالثة تكون تحت النقطة الأولى بـ 5 سم (عند العمود العجزي تقريباً).
- نطلب من المريض أن ينحني إلى الأمام، فيجب أن **تزداد المسافة العلوية** (بين النقطة الأولى والثانية) **بمقدار 5 سم**، فإذا زادت بمقدار أقل من ذلك هذا يدل على وجود **تحدد في العمود الفقري**.
- أما **المسافة السفلية** (بين النقطة الأولى والثالثة) **يجب أن تبقى ثابتة** وإذا تغيرت نستنتج أن النقطة الأساسية قد أخذت بشكل خاطئ.





يوضح الشكل في الأعلى اختبار شوبر لتقييم حركة العطف في العمود القطني (في الحالات الطبيعية تزيد المسافة العلوية بمقدار 5 سم)

مقطع فيديو يوضح اختبار شوبر

- الاختبارات 2 - 3 - 4 - 5 هي اختبارات خاصة لمرضى اعتلالات الفقار فقط. *
- إثراء: تُصنف اعتلالات الفقار بحسب أحدث الأبحاث إلى ستة أنماط: التهاب الفقار اللاصق (المقسط) - التهاب المفاصل الصدافي - التهاب الفقار المرافق لآفات الأمعاء الالتهابية (داء كرون والتهاب الكولون التقرحي) - التهاب المفاصل الارتكاسي - التهب الفقار اللامتمايز - التهاب الفقار المرافق للالتهاب عنبة العين. *

EXTRA

↙ خُلاصة آربسيزية:

الاختبار	أهميته	آليته	القيمة الطبيعية
اختبار قذال - حائط	الكشف عن التحدد في حركة البسط للعمود الرقبي	قياس المسافة بين القذال والحائط	▪ المسافة الطبيعية بين القذال والحائط = 0. ▪ إذا **زادت** دل ذلك على التحدد.
اختبار زنمة - حائط		قياس المسافة بين الزنمة والحائط	▪ المسافة الطبيعية بين القذال والحائط = 10 سم. ▪ إذا **زادت** دل ذلك على التحدد.
اختبار الاتساع الصدري	تحديد مدى اتساعية العمود الظهري (الصدري)	قياس المسافة بين نقطتين على جدار الصدر في مستوى الحلمتين وذلك أثناء كل من الشهيق والزفير	▪ تتغير (تزداد) المسافة ما بين الشهيق والزفير لأكثر من 4-5 سم. ▪ إذا كان مقدار تغير المسافة **أقل** من ذلك إذاً يوجد تحدد.
اختبار شوبر	الكشف عن التحدد في حركة العطف الأمامي للعمود القطني	قياس مقدار تباعد الفقرات عن بعضها أثناء الانحناء عبر تعيين ثلاث نقاط تحدد فيما بينها مسافة علوية ومسافة سفلية	▪ تزداد المسافة العلوية بمقدار 5 سم. ▪ إذا كان مقدار زيادة المسافة **أقل** من ذلك إذاً يوجد تحدد.

بعض إصابات وتشوهات العمود الفقري

❖ تكون الإصابات إما **ميكانيكية** (فتق نواة لبية، تضيق قناة شوكية) أو **التهابية** (تصيب المفاصل الزليلة كالداء الرثياني) أو **إنتانية** (السل ويُدعى في هذه الحالة داء بوت، الحمى التيفية، الحمى المالطية *).

❖ **العمود الرقبي** هو الجزء الوحيد من الفقار الذي يحوي مفاصل زليلية بالإضافة للمفاصل الغضروفية، إذاً فهو الوحيد الذي يصاب **بالآفات الالتهابية كالداء الرثياني** (يحدث فيه ما يُدعى تحت الخلع الفهقي الفائقي) وهنا يجب الانتباه وتوخي الحذر عند خضوع هذا المريض لعمليةٍ ما والحاجة للقيام بالتنبيب (في التنبيب نحتاج لإجراء فرط بسط عند الرقبة) وذلك خوفاً من حدوث شلل رباعي (تحدث إصابة نورون علوي *).

❖ أما إذا كان لدينا مريض يعاني من الداء الرثياني واشتكى من **ألم في ظهره فلا تكون الاصابة بسبب الداء الرثياني** (لا توجد مفاصل زليلة هُنا) ويجب أن نبحث عن أسباب أخرى كالانهدام الفقري أو الكسور بسبب تخلخل العظام نتيجة الستيروئيدات القشرية التي يتناولها المريض لعلاج الداء الرثياني.

الجنف Scoliosis:

☑ هو **الانحناء الجانبي** للعمود الفقري، قد يكون **خلقياً أو مكتسباً** (كالرضوض أو آفات مفصلية كالسل).

☑ قد يكون **بسيطاً** بشكل C أو **مركباً** بشكل حرف S.

☑ **الفحص**: يكون الجنف واضحاً بالتأمل وقد نتحرى عنه كما يلي:

← نطلب من المريض القيام بالعطف (الانحناء) للأمام، ثم نقوم بجس النواتئ الشوكية، ثم نضع علامة بالقلم عند كل ناتئ.

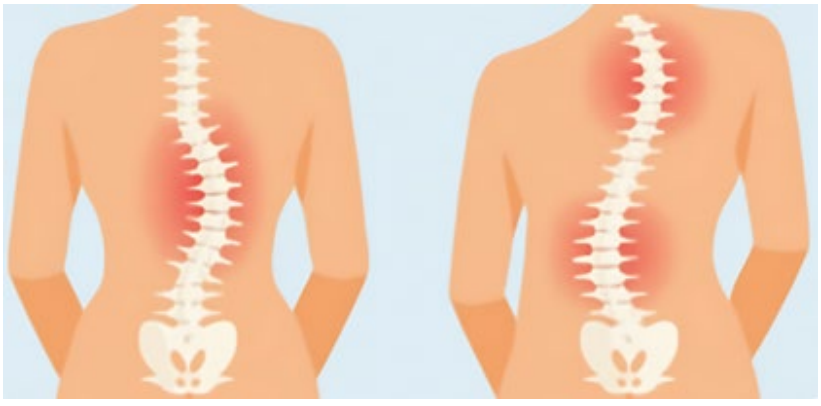
← بعدها نطلب من المريض الوقوف، فإذا كانت النقاط مستقيمة فلا يوجد جنف، أما إذا كانت النقاط منحرفة فالتشخيص جنف.

☑ للجنف نوعان: **وضعي وحقيقي**، نميز بينهما بالفحص السريري حيث نطلب من المريض أن ينحني للأمام:

← إذا كان الجنف **وضعياً** يستقيم العمود الفقري، يتألم المريض، ومن ثم يعود العمود الفقري لطبيعته.

← أما إذا كان الجنف **حقيقياً** يبقى حرف الـ S ويظهر حدب في الطرف المعاوض للجنف وتصبح البنية العضلية بجهة الميلان أوضح وأكبر.

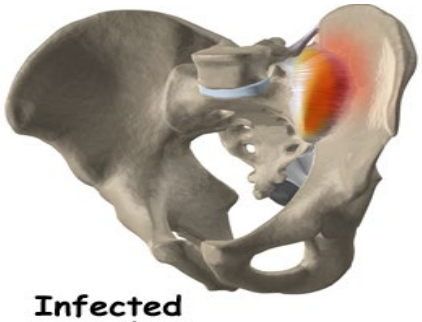
جنف مركب من النمط S



جنف بسيط من النمط C

المفصلان العجزيان الحرقفيان Sacroiliac joints

- يقعان أسفل العمود الفقري ويشكلان جزءاً من الحلقة الحوضية ولذلك فهما **غير متحركين**.
- يعتبر **الشوك الحرقفي الخلفي العلوي** نقطة اتصال الثلث العلوي للمفصل بثلثيه السفليين، أي يتم تحديد موقع المفصلين العجزيين الحرقفيين عن طريق تحديد الشوكين الحرقفيين الخلفيين العلويين.
- وبشكل أدق، نقوم بتعيين منطقة العرف الحرقفي حيث يكون المريض مستلقياً على بطنه وننزل مسافة 1 إنش (تقريباً 2.5 سم) أسفل منها ونبتعد عن الخط المحوري للنواتئ الشوكية أيضاً مسافة 2.5 سم أفقياً وعند هذه النقطة يكون التقاء الثلث العلوي مع الثلثين السفليين للمفصلين العجزيين الحرقفيين.


Infected sacroiliac joint

- يصابان **بالآفات الالتهابية** وأشيعها اعتلالات الفقار **والالتهابات الإنتانية** كالسل والحمى المالطية **والالتهابات الميكانيكية**.
- نتحرى الإيلام بالضغط براحتي اليدين، كما يوجد بعض الاختبارات الخاصة التي تؤدي إلى توتير الحلقة الحوضية لتحري الإصابة **كاختبار فابير باتريك والتوتير (التمطيط) وغانسلين**.

إثراء: اختبار FABER لِ باتريك أو اختبار الشكل 4:



- نطلب من المريض الاستلقاء ووضع ساقه بوضعية العطف Flexion مع القيام بالتبعيد Abduction والدوران الخارجي للورك External Rotation (FABER) فتصبح ساقاه بشكل رقم 4، ونتحرى وجود الألم في هذه الوضعية (في الوقت ذاته نثبت الجانب الآخر من الحوض).

إثراء: اختبار غانسلن:

- نطلب من المريض الاستلقاء على حافة السرير مع إنزال إحدى ساقيه من السرير، نتحرى وجود الإيلام عبر القيام بفرط بسط هذه الساق مع فرط عطف الساق الأخرى.



↙ حالة سريرية: شاب يشكو من ألم أسفل الظهر، يجب أن نميز هل الإصابة التهابية في العجزين الحرقفيين أم ميكانيكية كفتق نواة لبية:

نقاط الاختلاف	إصابة المفصل العجزي الحرقفي	فتق النواة اللبية
الألم	يكون الألم **ثنائي الجانب** وذلك لوجود مفصلين، فتارةً يتألم المريض من جهة اليمين وتارة من جهة اليسار	الألم **وحيد الجانب** لأن القرص الغضروفي غالباً ينفتق في جهة واحدة
طبيعة الألم	التهابي (أشد صباحاً مع يبوسة أكثر من نصف ساعة ويتحسن بالحركة)	ميكانيكي (الألم يزداد بالحركة)
انتشارات الألم	ينزل الألم إلى الإلية والوجه الخلفي للفخذ ويتوقف عند الحفرة المأبضية	ينزل الألم على طول الساق
الآفات العصبية المرافقة	لا يترافق مع أعراض عصبية كالخدر والتنميل	يترافق بخدر ونمل وغياب المنعكسات

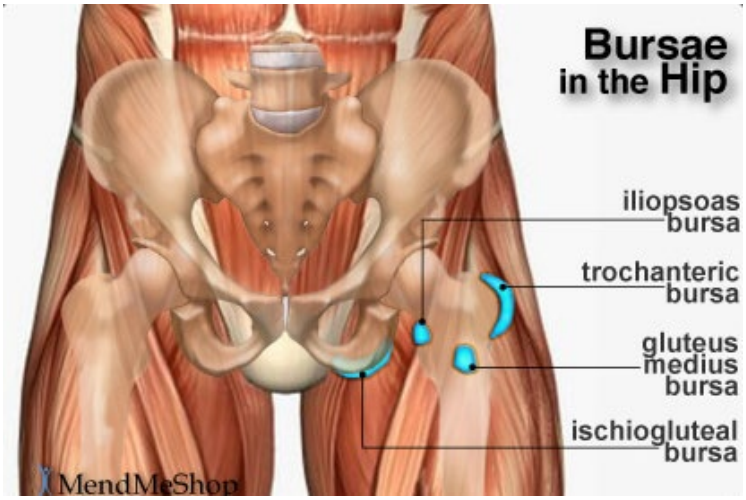
مفصل الورك Hip Joint

- مفصل كروي محاط بأمتن رباط في الجسم وبطبقة عضلية سميكة نسبياً وبالتالي يعد **مفصلاً عميقاً**.
- ويتميز ما حول المفصل بوجود **العديد من الأجربة** التي يمكن أن تصاب وهي:

الجراب فوق المدور الكبير

جراب البسواس

الجراب الإسكي أو الإليوي



الأعراض الرئيسية:

☑ **الألم في مفصل الورك:** وهو ألم في الناحية المغبنية، ينتشر على الوجه الأمامي للفخذ أو الإلية، أو قد يكون محصوراً بالركبة.

← يُعد انتشار الألم في مفصل الورك إلى الركبة نقطة هامة حيث يمكن أن يشكي المريض من ألم في ركبته وبالفحص نكتشف أن ركبته سليمة ولكن هناك تحدد أو إيلام في حركات مفصل الورك.

☑ **العرج:** ليس شرطاً أن يكون من الورك وغالباً يعرج المريض **باتجاه الجهة المصابة** وقد يترافق بألم.

فحص مفصل الورك

❖ لفحص مفصل الورك نجعل المريض يستلقي على ظهره بحيث **يكون الحوض متناظراً** وليس مائلاً، والشوكتين الحرقفيتين العلويتين على نفس المستوى.

❖ في فحص مفصل الورك **نتخطى مرحلة التأمل** لأنه مفصل عميق لا تظهر عليه العلامات الالتهابية، وننتقل فوراً إلى الجس والحركة.

أولاً: الجس Palpation:

☑ يجس الألم في منتصف الرباط الإربي.[1]

☑ نلاحظ نقاط العلام وهي:

المدور الكبير	العرف الحرقفي	الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية	الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية
الحدبة الإسكية أو الأليوية	العجز	العصعص	

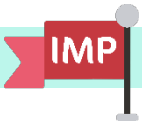
هذه النقاط كلها مهمة جداً حيث قد تكون مكان لارتكاز بعض الأوتار وبالتالي فهي مهمة للتمييز بين الإصابات الوترية وإصابات الجوف المفصلي.

↙ أما أهم نقاط العلام فهي:

1. المفصل الحقاني الفخذي Femoral-Acetular Joint:

✓ الذي يوافق منتصف الرباط الإربي.

2. الجراب المدوري الكبير Trochanteric Bursa:



✓ يقع على جانبي الحوض ويعتبر التهابه شائعاً جداً.

✓ **نقوم بفحصه كما يلي:** نطلب من المريض الجلوس جانباً على طاولة الفحص، ونطبق ضغط عميق على جانب ورك المريض فيتألم المريض، ويشكي عادةً من عدم قدرته على التقلب على جنبه أثناء النوم.

[1] عندما تكون الإصابة في جوف مفصل الورك يظهر الألم في الناحية المغبنية أي منتصف الرباط الإربي. *

ثانياً: فحص الحركة Movement:

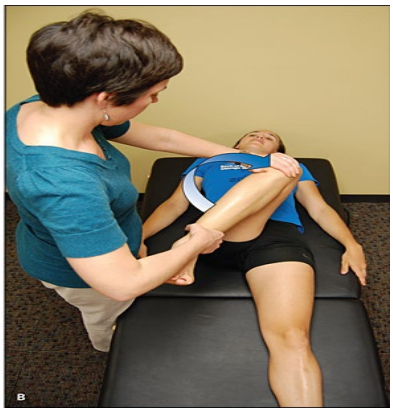
☑ حركات مفصل الورك هي: العطف، البسط، التقريب، التبعيد، الدوران الداخلي، الدوران الخارجي.



تحري العطف



تحري البسط



تحري الدوران الداخلي



تحري الدوران الخارجي



تحري التقريب



تحري التبعيد

بعض اختبارات فحص مفصل الورك

1. اختبار توماس Tomas Test:



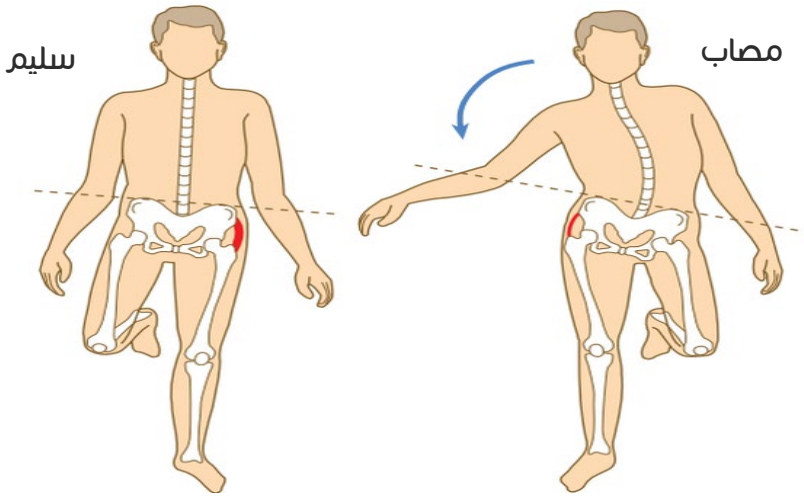
- يتم إجراء اختبار توماس لمعرفة ما إذا كانت زيادة القعس القطني لدى المريض ناتجة عن وضعية معاوضة بسبب **تشوه ثابت حقيقي** بالانعطاف في مفصل الورك أو أنها **لسبب فيزيولوجي طبيعي**.
  - من الحالات الفيزيولوجية التي يزداد فيها القعس القطني البدانة وعند السيدات أثناء الحمل وخاصة الأشهر الأخيرة.
- نقوم بعطف أحد الطرفين السفليين لأقصى قدر ممكن، في الحالة الطبيعية يستطيع الشخص السوي **إبقاء الطرف الثاني بوضعية البسط**.
- أما **غياب البسط الكامل** بالطرف الممدود **المقابل** للطرف الذي يعطفه الطبيب، يعني وجود **تشوه ثابت بالانعطاف في مفصل الورك بهذا الطرف** (أي الطرف الممدود).

2. اختبار ترينديلينبرغ Trendelenburg Test:

- وهو اختبار لتحري وجود **اعتلال عضلي داني أو أذية في مفصل الورك**.
- يطلب من المريض الوقوف على طرف واحد مدة 30 ثانية، ثم على الطرف الآخر.

في الحالة السوية عندما يرتفع الطرف السفلي السليم عن الأرض **يميل الحوض للأعلى في هذه الجهة المرفوعة** (أي يرتفع الورك غير الحامل للثقل وهو نفسه الورك في جهة الساق المرفوعة).

ولكن عند الشخص المصاب باعتلال عضلي داني أو أذية في مفصل الورك **يميل الحوض نحو الأسفل عوضاً أن يرتفع** في ناحية الطرف المرفوع عن الأرض (أي يحدث تدلي الورك للأسفل في الجهة غير الحاملة للثقل) ويكون الاختبار إيجابياً.



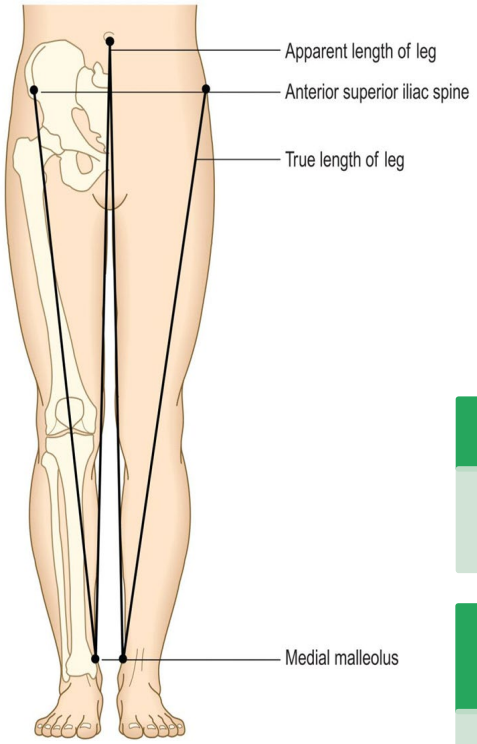
مقطع فيديو يوضح فحص مفصل الورك

قياس الطول الحقيقي والطول الظاهر للطرفين

☒ في كثير من الأحيان يأتي الأهل إلى الطبيب من أجل طفل يعاني من عرج أو اختلاف بطول الطرفيين السفليين عن بعضهما، فنقوم بقياس الطول الحقيقي والطول الظاهر.

☒ **الطول الحقيقي**: من الشوك الحرقفي الأمامي العلوي حتى الكعب الإنسي.

☒ **الطول الظاهر**: من السرة حتى الكعب الإنسي.

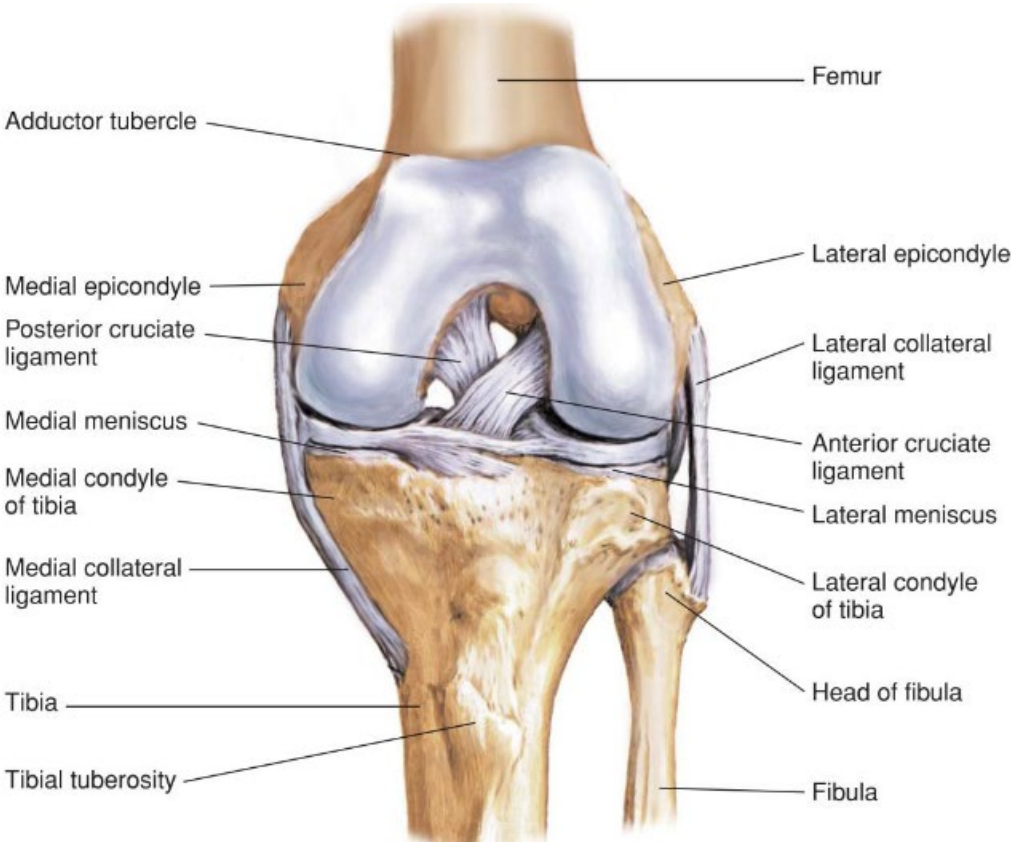


نميز الحالات الآتية:

اختلاف في الطول الحقيقي	اختلاف في الطول الظاهر
• توجد أذية وركية.	• يوجد ميلان في الحوض.
الطولين متناظرين	**الطول الظاهري ناقص والطول الحقيقي طبيعي**
• الحالة طبيعية.	• يوجد تشنج عضلي.

مفصل الركبة Knee joint

- مفصل الركبة من أهم المفاصل لأنه يصاب بكل الأمراض تقريباً، وهو **مفصل سطحي** وبالتالي تظهر عليه كل العلامات الالتهابية.
- يوجد في مفصل الركبة جوفان مفصليان:
  1. الجوف بين الداغصة والفخذ.
  2. الجوف بين الفخذ والظنبوب.



والآن ننتقل لفحص مفصل الركبة كما اعتدنا: التأمل، الجس، الحركات، ويُضاف إليها بعض الاختبارات ..

فحص مفصل الركبة

أولاً: التأمل Inspection:

☑ في التأمل نبحث عن ما يلي:

الاحمرار	التورم	الآفات الجلدية	التشوهات	التورمات

ثانياً: الجس Palpation:

☑ نقوم بجس الحرارة.

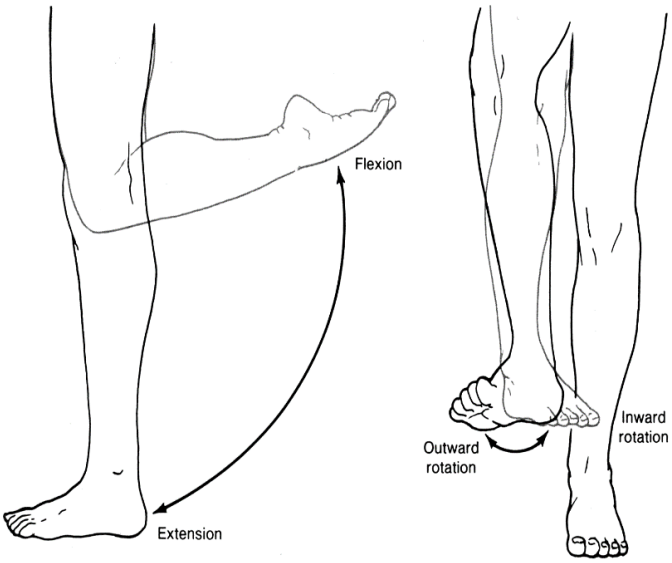
ثالثاً: فحص الحركة Movement:

☑ تتحرك الركبة **على محور واحد**، إذ تقوم بحركتي **العطف والبسط** (وهما الحركتان السريريتان الرئيسيتان).

☑ وبما أنها مفصل لقيمي تستطيع القيام **بحركات تدويرية خفيفة**، تحدث هذه الحركات عندما يكون الحوض والفخذ مثبتين، وقد تكون بنتيجة تحريك الظنبوب على الفخذ.

☑ **فحص عطف الركبة**: الشخص السوي يستطيع لمس الكاحل بالإلية أثناء عطف الركبة إلى الخلف.

☑ في أثناء الحركة نتحرى **الإيلام والفرقعة**.



والآن ننتقل لدراسة إصابة شائعة في مفصل الركبة ..

تورّم مفصل الركبة

الأسباب:

التهاب الغشاء الزليل	الانصباب في الركبة	الضخامة العظمية

الركبة هي أشيع مفصل يُصاب بالتهاب المفاصل الخمجي (الإنتاني) الجرثومي. *

أماكن بدء الأذية الأساسي:

في الداء الرثياني	في الغشاء الزليل
في الداء التنكسي	في الغضروف
في اعتلالات المفاصل الفقارية والتهاب الفقار المقسط	مكان ارتكاز الأربطة والأوتار على العظم

تحري الانصباب:

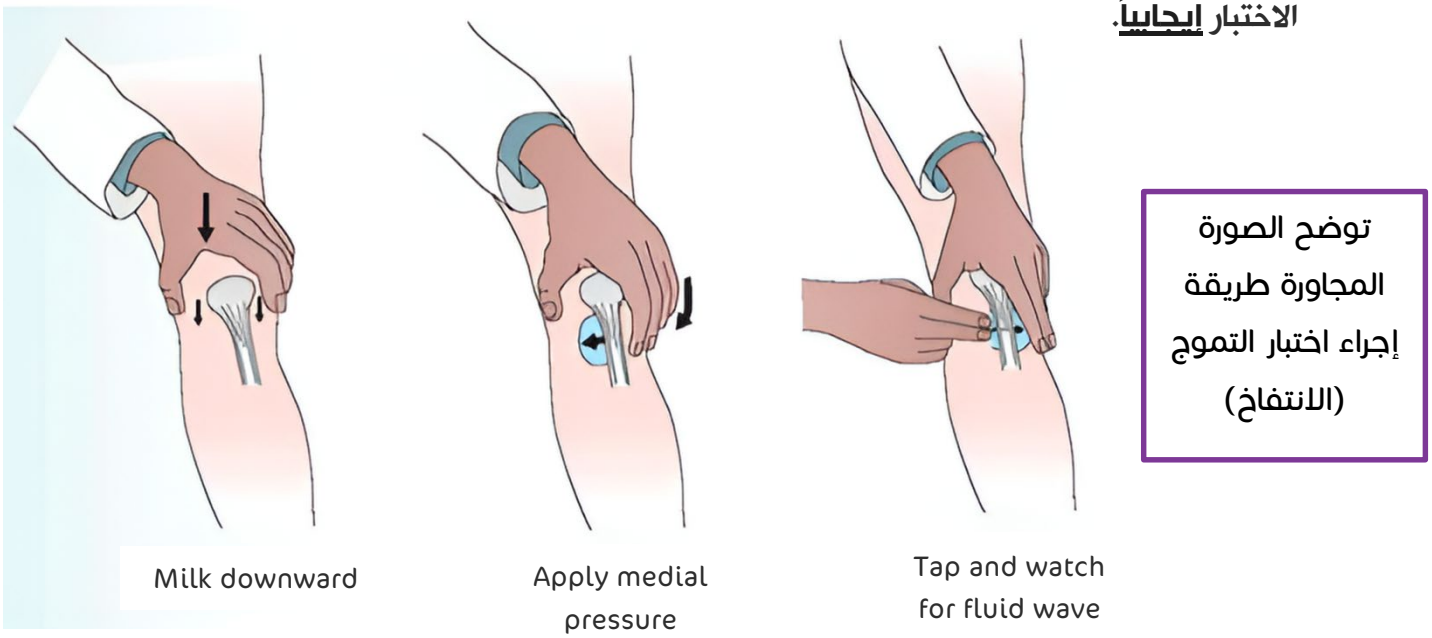
☑ يكون عن طريق نهز الداغصة أو علامة التموج.

1. **في الانصبابات الكبيرة** نستخدم اختبار **نهز الداغصة** Patellar tap:

- نطلب من المريض بسط الركبة، ثم نقوم بإفراغ الجيب فوق الداغصة من خلال النزول باليد اليسرى إلى أسفل الفخذ حتى الوصول للحافة العلوية للداغصة.
- ابقِ يدك هناك واستخدم اليد اليمنى بالضغط بشكل ثابت وسريع على الداغصة.
- إذا كان هناك انصباب ستشعر **بارتطام الداغصة بالفخذ** ويكون الاختبار **إيجابياً**.

2. **في الانصبابات الخفيفة** نستخدم اختبار **علامة التموج** Bulge test:

- نضغط على الجيب فوق الداغصة Milk suprapatellar pouch وذلك لإنزال السائل للجوف المفصلي.
- نستنزف المحتوى الإنسي Drain medial component.
- نمسك الجزء الوحشي Brush down lateral compartment **فإذا انتفخ الجانب الإنسي** يكون الاختبار **إيجابياً**.



توضح الصورة المجاورة طريقة إجراء اختبار التموج (الانتفاخ)

فيديو يوضح علامة التموج

فيديو يوضح علامة نهز الداغصة

والآن ننتقل لأهم ما يجب فحصه في منطقة الركبة ومن ضمنها مفصل الركبة ..

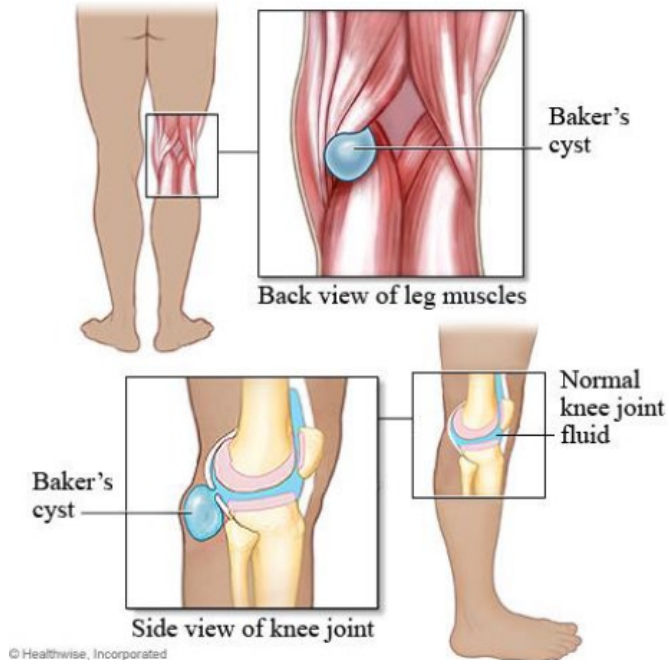
الفحص المُفصّل للركبة

نركز في فحص الركبة على:

- فحص مفصل الركبة بالخطوات السابقة
- فجص الغضاريف الهلالية
- مرتكزات الأوتار
- كيسة بيكر
- فحص الأربطة الجانبية
- الأجربة
- فحص الداغصة
- فحص الأربطة المتصالبة

IMP الكيسة المأبضية Popliteal cyst (كيسة بيكر Baker's cyst)

- تعتبر كيسة بيكر شكاية شائعة وتحدث في سياق **الداء التنكسي أو داء الروماتويدي (الداء الرثياني)**.
- حيث أنه في حالات التهاب الغضروف أو الانصباب الغزير تتمزق المحفظة المفصلية ويدخل السائل إلى الأجربة الموجودة في الحفرة المأبضية فتتشكل **كيسة غير نابضة مع تورم واحمرار**.
- في حال ازداد الضغط داخل الكيسة (بسبب سجود مفاجئ مثلاً) وتمزقت، يُمكن أن ينتشر السائل للأسفل **فتتوذم منطقة الربلة**، وقد يتسرب السائل بين البنى العضلية للركبة مسبباً أعراضاً **تشبه أعراض التهاب الوريد الخثري**.
  - ← نميز بين تمزق كيسة بيكر وبين التهاب الوريد الخثري **بالايكو دوبلر**، حيث يكون **طبيعياً في تمزق كيسة بيكر**.
- علاج كيسة بيكر: *
  - ← **كيسة غير متمزقة:** نعالجها بالبزل، وإذا لم تُشفى بالبزل المتكرر نستأصلها جراحياً.
  - ← **كيسة متمزقة:** نُعالجها بالراحة ومضادات الالتهاب للاستيروئيدية.



فحص الداغصة والجراب أمام الداغصة

☒ تشكل الداغصة جوفاً مفصلياً بينها وبين الفخذ.

☒ آفاتها قليلة فقد تصاب في **الداء التنكسي** أو بمرض يدعى **تلين الداغصة** والذي يؤدي إلى داء تنكسي مبكر.

أول مفصل يصاب بالداء الرثياني هو المفصل الرضفي الفخذي.

↙ نميز بين التهاب المفصل والتهاب الجراب أمام الداغصة:

في التهاب المفصل	في التهاب الجراب
• تزول كل تضاريس المفصل ومعالمه الطبيعية.	• يكون تورم المفصل محدداً وواضحاً.

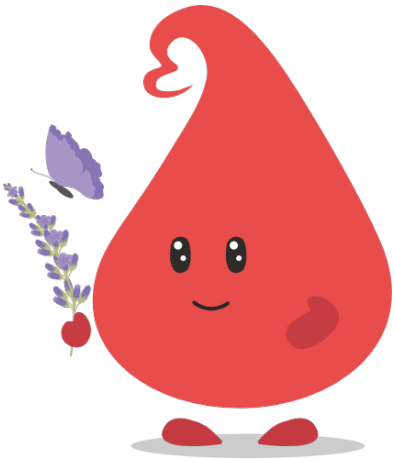




اختبارات الثباتية Tests of stabilit (لفحص الأربطة)

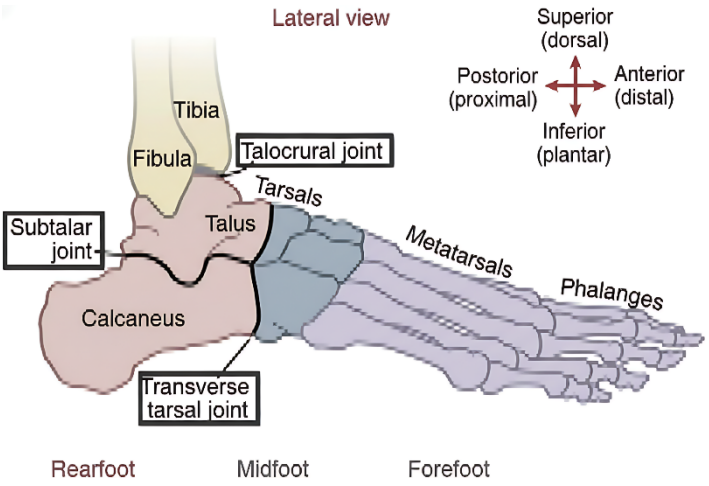
فحص الأربطة المتصالبة (الخلفي والأمامي)	فحص الأربطة الجانبية (الوحشي والإنسي)	فحص الغضاريف الهلالية
"علامة الجارور - اختبار لاشمان"	"الترويح - التفحيج"	"اختبار ماكموري"

يوضح الفيديو المجاور طريقة فحص مفصل الركبة



مفصل الكاحل Ankle joint

- عند الفحص يكون المريض مستلقي والكاحل زاوية قائمة، حيث نفحص القدمين بشكل متناظر.
- يوجد في الكاحل جوفان مفصليان يجب فحصهما:
  1. المفصل بين الظنبوب والقعب (المفصل القعبي Talar).
  2. المفصل بين القعب والعقب (المفصل تحت القعبي Subtalar).



فحص مفصل الكاحل

أولاً: التأمل Inspection:

☑ في التأمل نبحث عن ما يلي:

الأظافر	الآفات الجلدية	الضخامات	التشوهات	التورمات

☑ يجب فحص أخمص قدم المريض، وإذا وجدنا أثفان[2] عند رؤوس الأمشاط في أخمص القدم هذا يدل على وجود **خلع أو تحت خلع المفاصل المشطية السلامية** تسبب للمريض مشاكل عند الاستناد، ونراها في **الداء الرثياني**.

من التشوهات المُشاهدة:

الإبهام الأروح Hallux valgus	انحراف جانبي ثابت لإبهام القدم على المحور الرئيسي، قد يكون بدئي عائلي وقد ينجم عن الداء التنكسي أو الروماتويدي
التشوه بشكل المخلب	تشوه ثابت بالانعطاف
تراص الأصابع (القدم المثلثية)	الداء الرثياني
الأصابع النقانقية	تشاهد في اعتلالات الفقار (التهاب المفاصل الصدافي *)
القدم المسطحة	غياب القوس القدمية

[2] منطقة من الجلد المتسمك في أماكن الضغط المكرر.



الأصابع النقانقية



تراص الأصابع



الإبهام الأروح



التشوه بشكل المخلب



Flat feet



Normal feet

ثانياً: الجس Palpation:

IMP

☑ نقوم بجس الحرارة.

☑ كما نتحرى النقاط الألمية بجس:

الكعبين الوحشي والإنسي	ارتكاز وتر أشيل	أسفل العقب	الأمشاط	المفاصل المشطية السلامية	المفاصل بين السلاميات

التهاب المفصل المشطي السلامي الأول مميز للنقرس الحاد (شائع عند كبار السن) ويكون المفصل مؤلماً بشدة محمراً ومتورماً.



توضح الصورة المجاورة التهاب المفصل المشطي السلامي الأول في سياق النقرس

☑ نجس **وتر آشيل** بحثاً عن العقيدات الرثيانية وعن التهاب الوتر، إذ يصاب بشكل أساسي عند مرضى **التهاب الفقار اللاصق**.

وتر أشيل لا يُحقن بالكورتيزون لأنه قد يسبب مشاكل كبيرة وقد ينقطع ويسبب هبوط بالقدم.

☑ أيضاً نفتش عن الإيلام بجس الوجه السفلي للعقب والذي قد يدل على **التهاب الصفاق الأخمصي** المشاهد في **اعتلالات المفاصل الفقارية سلبية المصل**، أو قد يكون **معزولاً**.



فحص وتر أشيل



فحص الصفاق الأخمصي

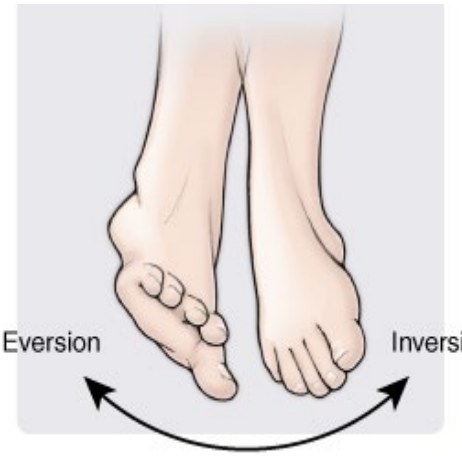
ثالثاً: فحص الحركة Movement:

☑ للكاحل 4 حركات:

← **حركات العطف والبسط**: تتم في المستوى **بين الظنبوب والقعب**.

← **الانقلاب للداخل والانقلاب للخارج** (تختلف عن الدوران): تتم في المستوى **بين القعب والعقب**.





مقطع فيديو يوضح فحص الكاحل

- نصل وإياكم إلى ختام المحاضرة -